



רגולציה ורפורמה בגריאטריה הכרונית - 2024

מאיה שקולניק גזית – R.N, B.A, M.H.A, Policy Management Specialist



האתגר ?



הכשרות
ופיתוח
15 נק'



מכרז החדש
2024



נתונים ל-
2024
והיסטוריית
המכרזים



מסגרות
ונותני שירות
בגריאטריה

תוכן עניינים

נותני שרות :

משרד הבריאות / משרד הרווחה / קופ"ח / ביטוח לאומי

משרד הבריאות
(גריאטריה כרונית)
- סיעודית ותשושי
נפש

קופת חולים (גריאטריה פעילה) -
סיעוד מורכב, שיקום, תתאקוטי,
הנשמה, מחלות גריאטריה פנימית

ביטוח לאומי –
גנלת סיעוד

דיור מוגן
וציבורי

משרד הרווחה –
תשושים

מסגרות
ונותני
שירות

אפשרויות לסידור מוסדי				
הגדרה	מי מגדיר את המצב התפקודי	סוג מוסד המתאים למצב	מקורות מימון	
אדם עצמאי בתפקוד יומיומי		דיור מוגן/בית אבות	מימון פרטי	אדם עצמאי בתפקוד יומיומי
אדם הזקוק לעזרה חלקית בפעולות היומיומיות כמו: אכילה, לבוש	משרד הרווחה על פי טופס תפקודי	דיור מוגן/בית אבות	מימון פרטי/משרד הרווחה	אדם הזקוק לעזרה חלקית בפעולות היומיומיות כמו: אכילה, לבוש
אדם שמצבו התפקודי הורע וקיימת לגביו הערכה שלאחר טיפול, שיקום והחלמה, יחזור במידה רבה למצבו התפקודי הקודם	צוות רפואי מטפל ואחות בקרה מטעם קופת חולים	מחלקה שיקומית בבית החולים	קופת חולים	אדם שמצבו התפקודי הורע וקיימת לגביו הערכה שלאחר טיפול, שיקום והחלמה, יחזור במידה רבה למצבו התפקודי הקודם
אדם הזקוק לעזרה מלאה ברוב או בכל הפעולות היומיומיות כמו: אכילה, לבוש	משרד הבריאות על פי טופס תפקודי	בית אבות מחלקה סיעודית	השתתפות במימון על ידי משרד הבריאות/ביטוחים סיעודיים	אדם הזקוק לעזרה מלאה ברוב או בכל הפעולות היומיומיות כמו: אכילה, לבוש
אדם שאינו מוגבל באופן פיזי (יכול להתהלך וכד') אך סובל מירידה בזיכרון, בשיפוט ובהתמצאות במידה כזו שמסכן את עצמו. אדם הזקוק לעזרה מלאה בכל משימות היומיום ולהשגחה בגלל מצבו הקוגניטיבי.	משרד הבריאות על פי טופס תפקודי	בית אבות מחלקה לתשושי נפש	השתתפות במימון על ידי משרד הבריאות/ביטוחים סיעודיים	אדם שאינו מוגבל באופן פיזי (יכול להתהלך וכד') אך סובל מירידה בזיכרון, בשיפוט ובהתמצאות במידה כזו שמסכן את עצמו. אדם הזקוק לעזרה מלאה בכל משימות היומיום ולהשגחה בגלל מצבו הקוגניטיבי.
אדם סיעודי הזקוק גם לטיפול רפואי, כגון: עירויים קבועים והתערבויות רפואיות קבועות אחרות.	צוות רפואי מטפל ואחות בקרה מטעם קופת חולים	בית חולים/בית אבות מחלקה לסיעוד מורכב	השתתפות במימון על ידי קופת חולים/אפשרות להחזר מביטוח סיעודי פרטי	אדם סיעודי הזקוק גם לטיפול רפואי, כגון: עירויים קבועים והתערבויות רפואיות קבועות אחרות.

© רעות - משפחה מטפלת כל הזכויות שמורות



האתגר ?



הכשרות
ופיתוח
15 נק'



מכרז החדש
2024



נתונים ל-
2024
והיסטוריית
המכרזים



מסגרות
ונותני שירות
בגריאטריה

תוכן עניינים

520 כ
ש



תעריף ממוצע ליום (15,600 ש"ח לחודש)

13,500 כ



מאושפזים במימון קוד המדינה
(כ 6000 נוספים בקוד פרטי)

2.5 כ
מיליארד ש



תשלום שנתי למוסדות במכרז
כ-700 אש"ח החזר מב.ל ומשפחות

600 כ



מחלקות
460 סיעודיים 140 תשושי נפש

3,500 כ



קודים חדשים בשנה

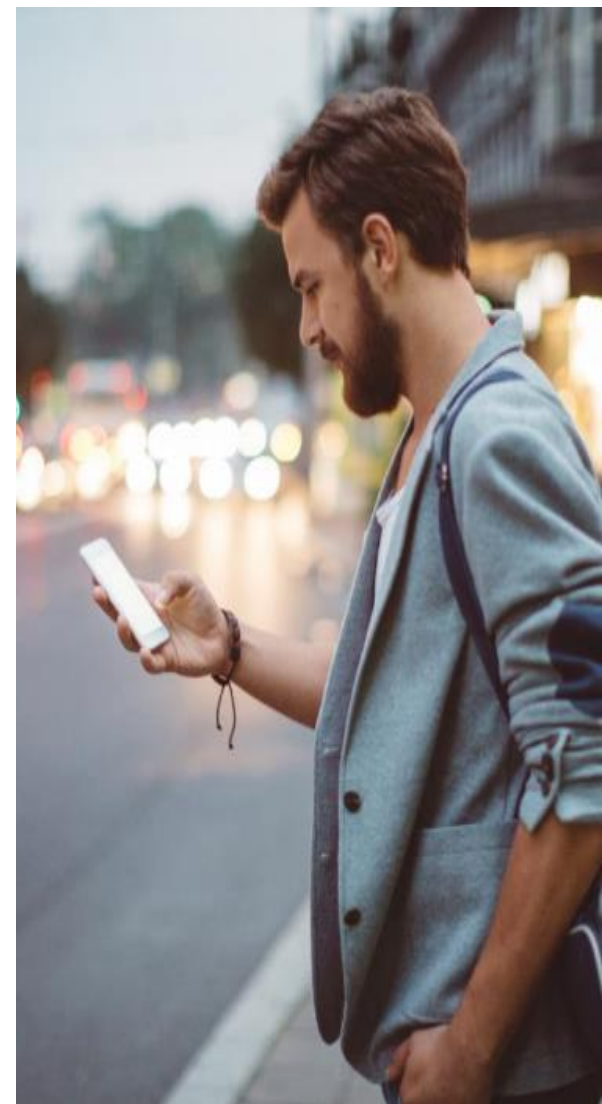
פטירות כ-4,000 בשנה

2.3 כ
שנים



שהות ממוצעת של מאושפז במוסד

נתונים – 2024

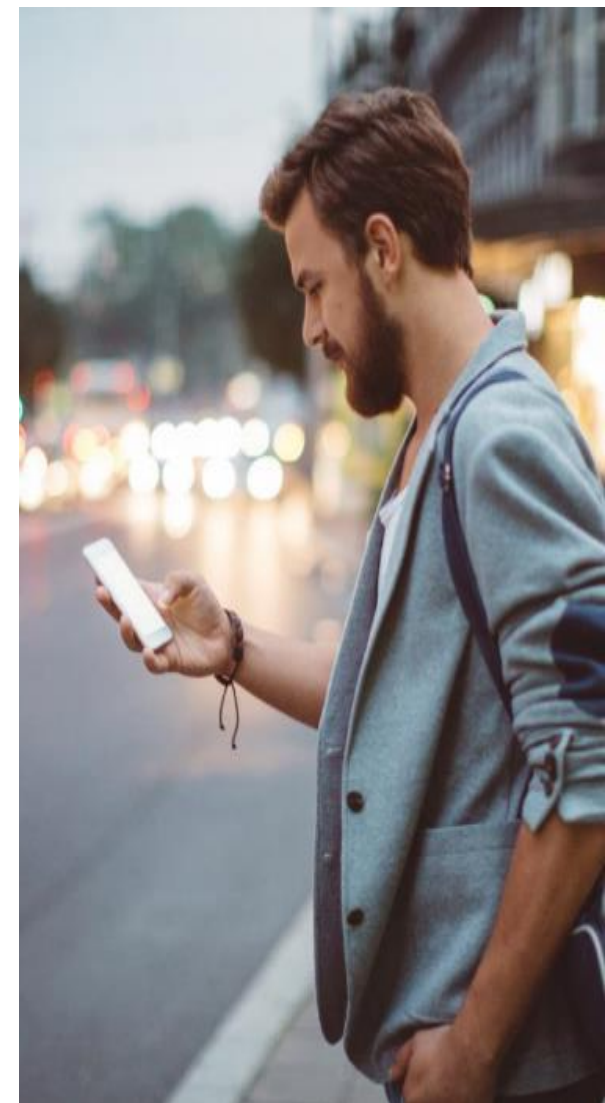


נתונים 2024 –

אוכלוסייה 75 + :
2020 – 434 אלף (4.7%)
2035 – 860 אלף (7.1%)

אחוז בני 65 השוהים במוסד עולה
עם הגיל –

0.6% : 74 – 65
2.1% : 84 – 75
6.75% : +85



היסטורית המכרזים

- פורסם מכרז חדש ל- 4 שנים
- נקבעה מתודולוגיה חדשה לחישוב תעריף יום אשפוז (סלים)
- לא הוגשה עתירה

2012

- פורסם מכרז חדש עם עדכונים
- למכרז היו התנגדויות רבות
- בעיקר בגין מחיר יום האשפוז
- לאחר דחיות רבות המכרז בוטל

2018

2008

2016

2024

- פורסם המכרז הארצי הראשון ל- 3 שנים
- המוסדות הגישו עתירה - כמעט בכל היבט
- פסק הדין התמקד במחיר יו"א - התעריף אינו מאפשר קיום בכבוד

- פורסם מכרז ל- 4 שנים
- התעריף התבסס על מכרז 2012
- מוסדות הגישו עתירה על תעריף
- פס"ד - הליך פרוצדורלי תקין

- פורסם מכרז חדש





האתגר ?



הכשרות
ופיתוח
15 נק'



מכרז החדש
2024



נתונים ל-
2024
והיסטוריית
המכרזים



מסגרות
ונותני שירות
בגריאטריה

תוכן עניינים

מכרז חדש עם שינוי

בתפיסת ההפעלה של בית חולים כבית –

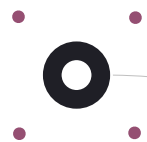
שינוי תפיסה –
התמקדות בצרכי
הדייר והעדפותיו

שינוי ארגוני –
העצמת הצוותים

שינוי פיזי –
יחידות דיור
פרטיות



שינוי בתפיסה



החזון

החיים במסגרת הסיעודית יהוו קהילה
וסביבת מגורים קבועה, ראויה,
איכותית, מקדמת בריאות ומועדפת על
הזקן ובני המשפחה וסביבת עבודה
נחשקת לצוות המקום.



תמרוץ לאיכות

מכרז 2024

נושאים	ניקוד
כללי- תשתית וציוד	2
סביבת הדייר ותנאי מחייה	8
תעודות ורישוי	8.5
הכשרות ופיתוח הצוות	14
תרבות, חיי פנאי וקשרי קהילה	10
ניהול סיכונים ובטיחות הדייר	7.5
שביעות רצון וקשר עם משפחות הדיירים	7.5
איכות חיי הדייר ביום יום	18
תכלול הטיפול בדייר	10
תזונה מיטבית מותאמת אישית	12.5
נושאים רוחביים	2

מכרז 2012

נושאים	ניקוד
תקופת רישיון	15
בקורות	30
בריאות הסביבה	5
השכלת הצוות	19
מומחיות רופא המחלקה ויועצים מומחים	19
מומחיות בגריאטריה מנהל רפואי	4
הרשאות למתן iv	4
רשומה רפואית ממוחשבת	4

רפואה – ירידה בתקינת מינימום רופא הבית
חובת הכשרה בגריאטריה למנהל הרפואי
חובה להעסיק יועץ גריאטרי



אחיות – ירידה בתקינת מינימום אחיות מוסמכות (לילה)
מתווה להפחתת שיעור אחיות מעשיות
אחות מעשית לא יכולה לשמש כאחראית משמרת או
מחלקה.



הרחבת מערך העוסקים בסיעוד - חוזר מנהל האחיות
2017

מטפלים – עליה בתקינה
חובת הכשרות
תמרוץ העצמה



תחומי עיסוק ופעילות של כוח עזר מיומן במערך האשפוז
והקהילה, חוזר מנהל הסיעוד 2020

תקינה

שעות העבודה השבועיות במשרה מלאה לצורך חישוב תקינת כח האדם הינן כדלקמן:

רופא	אחות	כח עזר	פיזיותרפיסט	תזונאי	מרפא בעיסוק	עובד תעסוקה	עובד סוציאלי
41.5	36	42	40	40	40	40	39

תקינת כוח האדם הנדרשת למחלקה של 36 מיטות סיעודיות

מקצוע	תקינה	הערות
רופא הבית	0.33	
יועץ גריאטר	6 שעות בחודש	עד 50% מהשעות ניתן לקיים בעבודה מרחוק
מנהל רפואי	8 שעות בחודש	עד 50% ניתן לקיים בעבודה מרחוק לפי שיקול המוסד
אחות	4.85	במוסד עם 3 מחלקות ומעלה - 4.85 תקנים במוסד עד 2 מחלקות (כולל) - 4.52 תקנים במוסד עד מחלקה אחת - 5.43 תקנים
כח-עזר	13.3	במוסד עם מחלקה אחת נדרש 12.3 תקנים

תקינה- מקצועות הבריאות

מקצוע	תקינה למחלקה (2012)	תקינה מינמום מחייבת למחלקה (2024)
פיזיותרפיסט	0.5	0.5
עובד סוציאלי	0.36	0.36
מרפא בעיסוק	0.18	0.09
תזונאי	0.18	0.12
רוקח	0.072	-
קלינאי תקשורת	0.023	-
כלל המקצועות		0.245
סה"כ תקן	1.315	1.315
עובד תעסוקה	0.5	1

בקורות וכלי בקרה

בקורות רישוי : ככלל מתוכננות **80%**
בקורות טיפול ראוי : פתע **20%**

✓ אורך הרשיון נקבע על פי סל האיכות

✓ כלי בקרה אחיד לכלל מקצועות הבריאות

✓ תיקוף הממצאים – סקר חווית המטופל / דייר
תקופתי אחת לשנה או שנתיים

✓ הנגשת ממצאי הבקורות + סקרים לציבור

[קישור למאגר כלי הבקרה באגף הגריאטריה](#)

בהתאם למפתח הבא:

1. סלי איכות 6-8 – רישוי לשנתיים
2. סלי איכות 4-5 – רישוי לשנה
3. סל איכות 3 – רישוי ל- 6 חודשים
4. סלי איכות 1-2 – רישוי ל- 3 חודשים



נהלים למסגרת גריאטרית (מחלקות סיעודיות ותשושי נפש)

סוג: נהלים והנחיות • יחידות: אגף גריאטריה • תאריך פרסום: 26.11.2025 • תאריך עדכון: 18.12.2025

עוד באותו נושא

אוגדן נהלי גריאטריה למחלקות סיעודיות ותשושי נפש

אוגדן נהלים לבית חולים גריאטרי

נהלים עבור מחלקות גריאטריה פעילה (סיעוד מורכב תומך, הנשמה ממושכת, גריאטריה שיקומית, גריאטריה תת אקוטית)

קובץ הנהלים למסגרת גריאטרית מהווה בסיס לעבודת המערך הגריאטרי במחלקות לגריאטריה ממושכת (מחלקות לסיעודיים ותשושי נפש).

קובץ הנהלים אינו מחליף חוזרים רלוונטיים מטעם משרד הבריאות ושירותי בריאות הציבור או כל מסמך מחייב אחר.

נהלי הקובץ חלים על כל המסגרות גריאטריות ברישיון משרד הבריאות שלהן מחלקות לדירים סיעודיים ותשושי נפש. קובץ הנהלים זה מתעדכן בימים אלו, ככל ולא קיימת התייחסות בקובץ נהלים זה, יש לפעול בהתאם לקובץ הנהלים לבית חולים גריאטרי. נהלים עבור מחלקות גריאטריה פעילה (סיעוד מורכב תומך, הנשמה ממושכת, גריאטריה שיקומית, גריאטריה תת אקוטית)

הקובץ נבנה בראייה רוחבית, תוך התמקדות בדייר ובצרכיו ובדגש על עבודת צוות רב מקצועי. הקובץ מחולק ל"נהלי רוחב", המתייחסים לעבודה הרב מקצועית ומחייבים את צוות המסגרת כולו. הפרקים הנוספים מציגים את נהלי התחומים המקצועיים.

נהלי רוחב

1.0.5.8 - מערך הפנאי וקשרי קהילה במסגרת הגריאטרית - טיוטא

נהלי אֶחִיזת

1.2.1.2 - תפקיד המטפל (כוח עזר) במסגרת הגריאטרית - טיוטא

נהלי פיזיותרפיה

1.6.0.1 - פיזיותרפיה: הערכות ארגונית והגדרת תפקידים - טיוטא

1.6.0.2 - טיפול פיזיותרפיה - טיוטא

1.6.0.3 - פיזיותרפיה: ציוד טיפולי והתאמת ציוד תומך למטופל - טיוטא

1.6.0.4 - כוח עזר בפיזיותרפיה - טיוטא

נהלי ריפוי בעיסוק

1.7.0.4 - מערך התעסוקה והפנאי - תכנון ויישום - טיוטא

נהלי קלינאות תקשורת

1.9.0.1 - קלינאות תקשורת במחלקות כרוניות - טיוטא

נהלים

פעילות הא"ת יות – בוצעו התאמות ותהליכי מיטוב

נערכין 23/11/2025 מכרז הקודים 2524

מרכז רפאה סיעוד ושקים

מס'	שם הרשומה	ניהול הרשומה לפי נהלי משרד הבריאות (נעילות אבות מערכתית)	מועד הפקת תדפיס
3.	מדור סיעודי :		
	אנמנה סיעודית	לא יאוחר מ-24 שעות מקבלה ראשונה ומאשפוז חוזר.	נעילת מערכת תוך 72 שעות
	תכנית טיפול סיעודית	- תוכנית ראשונית תוך 72 שעות מיום קבלה. - תוכנית כוללת לא יאוחר מחודש מיום הקבלה ובשיתוף צוות רב מקצועי. - בהמשך אחת לשנה ולפי הצורך (הוספת התערבות והערכה לבנייה הקיימת).	תיק דיגיטאלי
	הערכה תקופתית יוזמה.	מקליטת המטופל שבוגיים עד חודש ובהמשך אחת לשנה לסמוך לשיבה רב מקצועית (בכל שינוי במצב).	נעילת מערכת תוך 72 שעות
	סימנים חיוניים מעקב כאב	סימנים חיוניים (דופק, לחץ דם, SAO2, חום) בקבלה ובשוטף לפי הדריאה הראשית / תוכנית טיפול / שיקול דעת אחוז בהתאם למצב רפואי. אומדן כאב ראשוני יש לבצע תוך 12 שעות מקבלה ולפחות אחת לשבוע. מטופל שקיבל טיפול נגד כאב יבוצע לפני (אחרי קבלת טיפול).	מדי
	מעקב סיעודי	אחת לשבוע ולפי צורך.	משמרת
	מעקב פצעים	סוג הפצע, מעקב וטיפול במצע יבוצע אחת לשבוע לפחות.	מדי
	אומדן פצעי לחץ + ניידות NORTON	- בקבלה וכולק מאומדן התקופתי (אחת ל-6 חודשים) או במידה וחל שינוי במצב המטופל. - בהיווצרות פצע פעם בחודש.	מדי
	אומדן סיכון לפגילות FARMER	תוך 24 שעות מקבלה לחולים בסטטוס סיעודי בהמשך בהתאם לשינוי במצבו והתקדדי.	מדי
	אומדן כף רגל סוכרתית	בקבלה עד 48 שעות מקבלתו ומעקב בהתאם לדרגות סיכון לפי רמות סיכון : 0 אחת לשנה דרגה 1 אחת ל-6 חודשים דרגה 2 אחת ל-3 חודשים דרגה 3 בתדירות הנדרשת עד לריפוי ואחייב אחת ל-3 חודשים.	מדי
	איתור אומדן דיכאון PHQ-2 GDS	במחלקה סיעודית תוך 7 ימים מקבלה ולפי צורך.	מדי
	שאלון בנושא שינויי התנהגות - COHEN MANSFIELD AGITATION INVENTORY	למטופלים הסובלים מדמנציה בקבלה בשבוע הראשון. הערכה חוזרת אחת לשנה-לסמוך לשיבה רב מקצועית וא/או לפי השינויים החלים אצל המטופל.	מדי
	רישום כלכלה	בקבלה ואחת לשנה קלדורית ולפי צורך.	נעילת מערכת תוך 72 שעות
	מעקב משקל	בקבלה ומעקב פעם בחודש	מדי
	סיקור תזונתי - SNAQ	- בקבלה תוך 10 ימים/כחלק מאנמנה סיעודית. - בהמשך בהתאם להערכה תקופתית יוזמה (אחד לשנה).	נעילה מיידיית
	אומדן פה	בקבלה תוך 10 ימים/כחלק מאנמנה ובהמשך אחת לשנה ובמקביל להערכה תקופתית יוזמה.	מדי

נערכין 23/11/2025 מכרז הקודים 2524

מרכז רפאה סיעוד ושקים

	הערכת יכולת בליעה	בקבלה תוך 10 ימים/כחלק מאנמנה ובהמשך אחת לשנה ובמקביל להערכה תקופתית יוזמה.	מדי	תיק דיגיטאלי
	אומדן שליטה על סוגרים	בגריאטריה הכרומית ופניולה בקבלה – לא יאוחר מ-72 שעות מהקבלה ובהמשך לפחות אחת לשנה במקביל להערכה תקופתית יוזמה ובכל שינוי במצב המטופל. כמו כן בכל מטופל עם צנטר שותן בתהליך גמילה יש לבצע אומדן. במטופלים עם חוסר יכולת לשיתוף פניולה ומטופלי טיפול תומך (מצב הכרה) לא מחויב.	מדי	תיק דיגיטאלי
	אומדן סיכון לצעירות	בקבלה ובהמשך אחת לשנה ובמקביל להערכה תקופתית יוזמה ובשינוי מצבו של המטופל.	נעילה מיידיית	תיק דיגיטאלי
	טיפול/ים הוראות	בקבלה ולפי שיקול דעה מקצועי-רפואי וסיעודי	מדי	תיק דיגיטאלי
	דף חלוקת תרופות (CARDEX)	לפי הוראות רופא	מדי	תיק דיגיטאלי
	ניהול זיהומים	ראה נוהל מוסדי מס' 1.10.3 נספח 3 המתעדכן לפי הנחיות היחידה הארצית למניעת זיהומים משרד הבריאות.	מדי	תיק דיגיטאלי
	חיסונים	המלצות משרד הבריאות ל : - שפעת – INFLUENZA - אחת לשנה נולמתי, מדד איכות שנה. - חיסון לפנימוקוקוס, נייפ הנחיות משרד הבריאות אגף האפידמיולוגיה PNEUMAVAX - אולוסיה עם מחלות רקע אחת ל-5 שנים אחרי גיל 65 חד פעמי.	מדי	תיק דיגיטאלי
	מכתב שחרור סיעודי	באת הפנייה לאשפוז אקוטי, שחרור לקהלה	בתלונה	תיק דיגיטאלי
מס'	שם הרשומה	ניהול הרשומה לפי נהלי משרד הבריאות	תוכנית אבות (נעילות מערכת)	מועד הפקת תדפיס
4.	מדור פארמאצי :			
	א. פיזיותרפיה	הערכת ראשונה : סיעודי: הערכה מלאה תוך שבוע מקבלתו. תשש נפש: הערכה מלאה תוך שבוע מקבלתו. מעקב : סיעודי: לפחות אחת ל-3 חודשים או בכל שינוי מצב תשש נפש: לפחות אחת ל-3 חודשים או בכל שינוי מצב	אבחון ראשוני- עד 7 ימים מהקבלה מעקב - תוך 3 ימים מרגע הביצוע	לפי הנחיות מנהלי תחום
	מבחן - FIM	לפי הצורך	מדי	תיק דיגיטאלי
	מבחן - Berg Balance Scale	לפי הצורך	מדי	תיק דיגיטאלי
	מבחן - Dynamic Gait Index	לפי הצורך	מדי	תיק דיגיטאלי
	מבחן - TUG	לפי הצורך	מדי	תיק דיגיטאלי
	ב. ריפוי בעיסוק	הערכת ראשונה : הערכה ראשונית מתבצעת עד שבועיים מיום הקבלה, וכוללת, תחומי ניסוק, הקשרים, שגרות ותפקידים. מעקב וטיפול : הערכה תקופתית לפחות אחת לשנה, יוזמה מקיפה בהתאם לצורך. הערכה מוללת את כל מרכיבי התפקוד והשתתפות הדייר תוך שימוש בכלי אבחון מתאימים סופס השאלת ציוד : בשחרור ולפי צורך.	הערכה ראשונית 14 ימים מרגע הביצוע מעקב - עד חודש מהקבלה	תיק דיגיטאלי
	ג. ע"ס	הערכת ראשונה : סופס רישום סוציאלי וגיליון קבלה- מעקב : במחלק החודש הראשון לקליטתו, השלמת ההערכה הביו-פסיכו-סוציאלי ובניית תוכנית טיפול המותאמת לצרכי הדייר. העובד הסוציאלי יזום תצפיות ושיתוף עם הדייר ומשפחתו לצורך הערכת הסתגלותו למסגרת והתערבות מקצועית בהתאם לצורך.	הערכה ראשונית 2 ימים. ע"ס	בשיקול דעת ע"ס

פעילות האָ ק יות – בוצעו התאמות ותהליכי מיטוב

הנחיות קבלת דייר חדש / בניית תוכנית טיפול			
אומדנים וסוגיות טיפול		אתריות ביצוע	טווח ביצוע
קבלה סיעודית ודיווח סיעודי:			
נזונים אישיים, דמוגרפיים, משפחתיים, חברתיים, מצב הכרה, היסטוריה רפואית ורמת התפקוד בעבר, תנאי מגורים - יש להתחשב לכל השורות ולא להשאיר שורות ריקות	בקבלה	נתינת תוך 24 שעות	פתיחתה באופן מלא בקבלה למוחזקת / בהובלה בן הפחיתות דלא קערי מסיי-סססס
	בקבלה	מעט בזמן במשך 72 שעות	דייר ללא אבחנה - מעקב מעט 6a חודשים, דייר מאובחן לא מאוזן - מעקב על פי הראות דומה עד להשגת איזון, לאחר האזון - מעט בחודש, דייר מאובחן ומאוזן - מעקב מעט בחודש, לאחר אירוע חריג - מעקב מעט במשמרת במשך 72 ש
ניטור סימנים חיצוניים : ל"ד (פי נוהל פנימי), דופק, סטורציה, חום	בקבלה	תוך 24 שעות	מעט בחודש / בהתאם למצב הדייר
שקילה	בקבלה	מקבלת הדייר	מעט בחודש / בהתאם למצב הדייר
אק"ג	בקבלה	תוך 24 שעות	דייר מאובחן יציב - מעט במשך / בהתאם למצב הדייר / בהתאם להוראות רפואות, דייר מאובחן לא מאוזן - מעקב על פי הראות דומה עד להשגת איזון.
מידת סוכר (ע"פי נוהל פנימי)	בקבלה	למשך 3 ימים	דייר ללא אבחנה - מעקב מעט בשבוע / בהתאם למצב הדייר / בהתאם להוראות רפואות, דייר מאובחן לא מאוזן - מעקב על פי הראות דומה עד להשגת איזון.
אומדן, מעקב ואיוון כאב / תכנית לטיפול בכאב	בקבלה	עד 12 שעות	דייר ללא אבחנה - מעקב מעט בשבוע / בהתאם למצב הדייר / בהתאם להוראות רפואות, דייר מאובחן לא מאוזן - מעקב על פי הראות דומה עד להשגת איזון.
חיעוד הפרשות שתן (תוך פירוט כמות מופרשת דרך קטטר שתון)	בקבלה	תוך 8 שעות	דייר ללא אבחנה - מעקב מעט בשבוע / בהתאם למצב הדייר / בהתאם להוראות רפואות, דייר מאובחן לא מאוזן - מעקב על פי הראות דומה עד להשגת איזון.
דיווח סיעודי (הכולל התייחסות לסוג הכלכלה ואופן האכלה, שניה, מצב התנהגות, השתתפות בתעסוקה, הפחיתות)	בקבלה	תוך 8 שעות	דייר ללא אבחנה - מעקב מעט בשבוע / בהתאם למצב הדייר / בהתאם להוראות רפואות, דייר מאובחן לא מאוזן - מעקב על פי הראות דומה עד להשגת איזון.
אומדן שלמות העור	בקבלה	תוך 8 שעות	דייר ללא אבחנה - מעקב מעט בשבוע / בהתאם למצב הדייר / בהתאם להוראות רפואות, דייר מאובחן לא מאוזן - מעקב על פי הראות דומה עד להשגת איזון.
התייחסות ל"בעיות חריפות" : שינוי במצב כללי של הדייר, בעת חזרתו של הדייר מאשפוז, אירועים / "כמעט אירוע" (מעקב סימנים חיצוניים + אומדן כאב + דיווח סיעודי פעם במשמרת במשך 3 ימים רצופים)	בקבלה	תוך 8 שעות	דייר ללא אבחנה - מעקב מעט בשבוע / בהתאם למצב הדייר / בהתאם להוראות רפואות, דייר מאובחן לא מאוזן - מעקב על פי הראות דומה עד להשגת איזון.
הגבלות	בקבלה	תוך 8 שעות	דייר ללא אבחנה - מעקב מעט בשבוע / בהתאם למצב הדייר / בהתאם להוראות רפואות, דייר מאובחן לא מאוזן - מעקב על פי הראות דומה עד להשגת איזון.
מעקב כלכלה - דייר עם פונד / PEG	בקבלה	תוך 8 שעות	דייר ללא אבחנה - מעקב מעט בשבוע / בהתאם למצב הדייר / בהתאם להוראות רפואות, דייר מאובחן לא מאוזן - מעקב על פי הראות דומה עד להשגת איזון.
מבחנים :			
אומדן פה סיעודי	בקבלה	תוך 24 שעות	דייר ללא אבחנה - מעקב מעט בשבוע / בהתאם למצב הדייר / בהתאם להוראות רפואות, דייר מאובחן לא מאוזן - מעקב על פי הראות דומה עד להשגת איזון.
אומדן סלע / סולם עצירות ניבוי (בהיעדר אבחנת עצירות)	בקבלה	תוך 24 שעות	דייר ללא אבחנה - מעקב מעט בשבוע / בהתאם למצב הדייר / בהתאם להוראות רפואות, דייר מאובחן לא מאוזן - מעקב על פי הראות דומה עד להשגת איזון.
ניבוי פצעי לחץ NORTON	בקבלה	תוך 12 שעות	דייר ללא אבחנה - מעקב מעט בשבוע / בהתאם למצב הדייר / בהתאם להוראות רפואות, דייר מאובחן לא מאוזן - מעקב על פי הראות דומה עד להשגת איזון.
אומדן שליטה על סוגרים	בקבלה	תוך 24 שעות	דייר ללא אבחנה - מעקב מעט בשבוע / בהתאם למצב הדייר / בהתאם להוראות רפואות, דייר מאובחן לא מאוזן - מעקב על פי הראות דומה עד להשגת איזון.
ניבוי נפילות FARMER	בקבלה	תוך 24 שעות	דייר ללא אבחנה - מעקב מעט בשבוע / בהתאם למצב הדייר / בהתאם להוראות רפואות, דייר מאובחן לא מאוזן - מעקב על פי הראות דומה עד להשגת איזון.
כף רגל סוכרתית (מבוצע לבעלי אבחנת סוכרת ע"פי פרוטוקול פנימי)	בקבלה	תוך 24 שעות	דייר ללא אבחנה - מעקב מעט בשבוע / בהתאם למצב הדייר / בהתאם להוראות רפואות, דייר מאובחן לא מאוזן - מעקב על פי הראות דומה עד להשגת איזון.
אומדן שניו התנהגות של הדייר (אצל חולים עם דמנציה / הפרעות נפשיות / טיפול תרופתי)	בקבלה	תוך 24 שעות	דייר ללא אבחנה - מעקב מעט בשבוע / בהתאם למצב הדייר / בהתאם להוראות רפואות, דייר מאובחן לא מאוזן - מעקב על פי הראות דומה עד להשגת איזון.
בניית תוכנית טיפול - בראש תוכנית טיפול לציין בעיות בגין הדייר התקבל (התייחסות ל ABL, יסולת תפקודית, הפרעות התנהגותיות לדיכאון / בדיד חברתי, כאב, שלמות העור, הגבלה פיזית, כישות, מפרת האזנות, בעיות אכילה, תוספי מזון, שמשי ש"ל"ה, מפרת נפילות, מפרת עצירות / מפרת פוער לחץ, תוספת, טיפול פליאטיבי) + ערכו הערכה תפקודית יומה	בקבלה	תוך 48 שעות	דייר ללא אבחנה - מעקב מעט בשבוע / בהתאם למצב הדייר / בהתאם להוראות רפואות, דייר מאובחן לא מאוזן - מעקב על פי הראות דומה עד להשגת איזון.
הערכת תוכנית טיפול (בשותוף צוות רב מקצועי)	בקבלה	תוך 10 שעות	דייר ללא אבחנה - מעקב מעט בשבוע / בהתאם למצב הדייר / בהתאם להוראות רפואות, דייר מאובחן לא מאוזן - מעקב על פי הראות דומה עד להשגת איזון.
הערכה תפקודית יומה תוך דגש על השוואה והתייחסות לשניו במצב לעומת בדיקה קודמת	בקבלה	תוך 10 שעות	דייר ללא אבחנה - מעקב מעט בשבוע / בהתאם למצב הדייר / בהתאם להוראות רפואות, דייר מאובחן לא מאוזן - מעקב על פי הראות דומה עד להשגת איזון.
שיחת תיאום ציפיות דייר צלול - התייחסות להנחיות "סוף חיים" / דייר צלול המוגדר כ"הנוטה למות" - "הנחיות מקדימות" מדייר עצמו או מבני משפחה של דייר הלא צלול	בקבלה	תוך 10 שעות	דייר ללא אבחנה - מעקב מעט בשבוע / בהתאם למצב הדייר / בהתאם להוראות רפואות, דייר מאובחן לא מאוזן - מעקב על פי הראות דומה עד להשגת איזון.
תיעוד שיחות משפחות (תיאום ציפיות)	בקבלה	תוך 10 שעות	דייר ללא אבחנה - מעקב מעט בשבוע / בהתאם למצב הדייר / בהתאם להוראות רפואות, דייר מאובחן לא מאוזן - מעקב על פי הראות דומה עד להשגת איזון.
תיעוד ביקורי משפחות	בקבלה	תוך 10 שעות	דייר ללא אבחנה - מעקב מעט בשבוע / בהתאם למצב הדייר / בהתאם להוראות רפואות, דייר מאובחן לא מאוזן - מעקב על פי הראות דומה עד להשגת איזון.
הורכת משפחות ותמיכה	בקבלה	תוך 10 שעות	דייר ללא אבחנה - מעקב מעט בשבוע / בהתאם למצב הדייר / בהתאם להוראות רפואות, דייר מאובחן לא מאוזן - מעקב על פי הראות דומה עד להשגת איזון.
קבלת סיעודית לאחר אשפוז ממשק עם הפחת הבית בנושא בקרת טיפול תרופתי	בקבלה	תוך 10 שעות	דייר ללא אבחנה - מעקב מעט בשבוע / בהתאם למצב הדייר / בהתאם להוראות רפואות, דייר מאובחן לא מאוזן - מעקב על פי הראות דומה עד להשגת איזון.
ישיבת צוות רב מקצועי (כל ראש תחום רשאי לפתוח ישיבה תוך ערכון שאר אנשי צוות רב מקצועי)	בקבלה	תוך 10 שעות	דייר ללא אבחנה - מעקב מעט בשבוע / בהתאם למצב הדייר / בהתאם להוראות רפואות, דייר מאובחן לא מאוזן - מעקב על פי הראות דומה עד להשגת איזון.



האתגר ?



הכשרות
ופיתוח
15 נק'



מכרז החדש
2024



נתונים ל-
2024
והיסטוריית
המכרזים



מסגרות
ונותני שירות
בגריאטריה

תוכן עניינים

הכשרה ופיתוח הצוות

(14 נק')



מאפייני הכשרות ועדכוני ידע



- ☐ ההכשרה יכולה להיות במסגרת מוסדית או חיצונית.
- ☐ חניכה (On the job training) על ידי עובד ותיק, צוות רב מקצועי.
- ☐ ההכשרה תכלול תכנים עיוניים ומעשיים.
- ☐ ניתן לשלב הכשרה עיונית באמצעים דיגיטאליים.
- ☐ תיעוד הכשרות וקבלת כתב מינוי.
- ☐ דוח מסכם של הכשרות העובדים ייבדק במסגרת הבקרה.
- ☐ הגדרת תהליכי עבודה בנהלים פנימיים
- ☐ תכנית הדרכות (חת"ש) מעודכנת אחת לשנה.

מאפייני הכשרות ועדכוני ידע



בתחום ההכשרות ישנם סעיפים בגינם יינתן ניקוד מקסימלי של 14 נק':

1. נאמני נושא 1 נק'.
2. תכנון מול ביצוע הדרכות חת"ש
3 נק'.
3. הכשרה בסיסית למטפלים 2 נק'.
4. מטפל בכיר – אחראי תחום 3 נק'.
5. שימוש באפליקציות מונגשות
לדווח 1 נק'.
6. תוכניות שימור וקידום עובדים
4 נק'.

מטפלים / כוחות עזר



קישור לנוהל מנהל
האחיות 2020

מטפלים / כוחות עזר חדשים

- בקליטה הכשרה ראשונית **18** שעות
- הכשרת המשך בשנה הראשונה – **40** שעות

58

כלל המטפלים וכוחות עזר מדי שנה

- פיתוח מקצועי (חת"ש) – **20** שעות
- הדרכה לעבודה במשמרת לילה – **4** שעות
- ~~פיתוח אישי/עדכון ידע~~ – **20 שעות בשנה** (פדיקור, תעסוקה...)

קורס הכשרה ראשוני

בסיסי

בן 3 ימים

5 נק'

(לפחות 18 שעות)

למטפלים / כוחות

עזר

תוכן עניינים-



הכשרה בהיבטים הבאים: -

1. טיפול בסיסי בדייר לרבות האכלה נכונה, רחצה, החלפת מכנסונים, שמירה על העור.

2. מעברים, handling בטיחות הטיפול (מטפל ודייר).

3. דיווח לצוות סיעודי במקרים של פגיעה בעור הדייר, נפילות ואירועים חריגים אחרים.

4. נושאים רלוונטיים המותאמים לסוג האוכלוסייה, המסגרת והמחלקה בה מועסק המטפל.

קורס הכשרה ראשוני

בסיסי

בן 3 ימים שיושלם

תוך שבוע

5 נק'

(לפחות 18 שעות)

למטפלים / כוחות

עזר

דוגמה !

נושא ההדרכה	תוכן	אחות	כוח עזר	זמן ההדרכה	אופן ההדרכה/מטודה	שם המנחה	תאריך ביצוע	חתימת המנחה
בטיחות הטיפול וניהול סיכונים (במהלך השבוע הראשון לקליטה)	• לומדה משרה"ב.	✓		שעה	ביצוע לומדה של משרד הבריאות			
	• מניעת נפילות מטופלים	✓	✓	שעה				
	• אירוע חירג ומבצע אירוע	✓	✓	30 דקות	צפה בסרטון וביצע			
זכויות החולה כבוד האדם (במהלך השבועיים לקליטה)	• ערכים ואתיקה, שמירה על פרטיות ובטיחות.	✓	✓	30 דקות	צפה בסרטון.			
	• חוק זכויות החולה	✓	✓	30 דקות				
	• חיסיון רפואי.	✓	✓	30 דקות				
שרות פיזיותרפיה במ"ג (במהלך השבועיים לקליטה)	• נידות.	✓	✓	30 דקות	צפה בסרטוני הדרכה, הדגמה, תירגול.			
	• מעברים	✓	✓	30 דקות				
	• שימוש באביזרי עזר (כ"ג/ /הליכון).	✓	✓	30 דקות				
	• שימוש במנף	✓	✓	שעה				
	• השכבה במטה פיזיולוגי	✓	✓	30 דקות				
שרות תזונה במ"ג (במהלך החודש הראשון לקליטה)	• מיקמי מזון ושתייה IDDSI	✓	✓	30 דקות	צפה בסרטונים וביצע לומדה לאתיות בנושא סיקור תזונתי של משרד הבריאות.			
	• דוח תזונה וחלוקת מזון	✓	✓	30 דקות				
	• ויטנים כלכלה יומי.	✓	✓	30 דקות				
	• לומדה לסיקור תזונתי, אופן ש"כילה ומעקב	✓	✓	30 דקות				
	• התנהגות אנטרלית	✓	✓	30 דקות				
כללי בטיחות בעבודה (במהלך השבוע הראשון לקליטה)	• בטיחות פיסית בעבודה ומניעת נפילות, הגבלה פיסית	✓	✓	שעה	צפה בסרטון.			
	• התמודדות בעת טריפה כולל מיפוי ציוד לכיבוי	✓	✓	30 דקות				
	• דרכי מילוט.							
טיפול תזונה (במהלך החודש הראשון לקליטה)	• מארג הדרכה ליישום חוק החולה הנטשה למות	✓	✓	30 דקות				
	• הצדקות טיפוליות לשוף החיים.	✓	✓	30 דקות				
	• ליווי רוחני							
סה"כ שעות הדרכה			19.5 שעות	18 שעות				

הרניי מאשרת בזה כי קיבלתי הדרכה, _____
חתימת המנהל/ת הישיבה: _____ חתימת מפקח חטיבה _____

* המסמך יתווק בתיק אחשי לעובד וידווח במייל למפקחת החטיבה.



טופס החתמה על הדרכה לעובדי האחיות וכוח עזר מיומן

עובד יקר, ברכות להצטרפות לצוות עובדי בית הדר, בהצלחה.
להלן רשימת הדרכות החובה שעליך לעבור כחלק מתהליך קליטתך בעבודה **בחדש הראשון** לקליטה בעבודה.
תהליך קליטה וליווי בפיקוח המנהל הישיר- אחות אחראית או איש מטעם, בסיום הדרכות מקוונות יש לחתום על
הטופס, מנהל ישיב והעובד ולתעד.

שם העובד: _____ תאריך קליטה בעבודה: _____

משרה: החלקית / מלאה
אופן העסקה: ישיבה / קבלן
מקצוע: אחות / כוח עזר

נושא ההדרכה	תוכן	אחות	כוח עזר	זמן ההדרכה	אופן ההדרכה/מטודה	שם המנחה	תאריך ביצוע	חתימת המנחה
הכרות ואוריינטציה (ביום הקליטה)	• זכויות העובד נהלי צנזרה תפקיד כוח עזר	✓	✓	30 דקות	צפה בסרטוני הדרכה, הדגמה, תירגול.			
	• הגיית ידיום וניגורניים.	✓	✓	30 דקות				
	• ניקוי וחיטוי ידיום -5 רגעים	✓	✓	30 דקות				
מניעת זיהומים (במהלך השבוע הראשון לקליטה)	• אירועי דקירה ממחטים	✓	✓	30 דקות				
	• כללי בידוד.	✓	✓	30 דקות				
	• שימוש באמצעי מגון	✓	✓	30 דקות				
	• לומדה	✓	✓	30 דקות				
	• התמודדות בעת ירי טילים.	✓	✓	30 דקות				
מצבי חרום כולל תשתיות חשמל (ביום הקליטה)	• התמודדות בעת ירי טילים.	✓	✓	30 דקות				
	• התמודדות בעת ירי טילים.	✓	✓	30 דקות				
	• התמודדות בעת אירוע ביולוגי חירג.	✓	✓	30 דקות				
	• התמודדות בעת טריפה.	✓	✓	30 דקות				
	• מוכנות להפסקת חשמל ממושכת (מעבר לשיטות ידנית, שימוש באמצע).	✓	✓	30 דקות				
שירות ריפוי בפוסק במ"ג (במהלך החודש הראשון לקליטה)	• שימוש בסדים וגלילים.	✓	✓	30 דקות	צפה בסרטונים והדגמה			
	• תפקיד: אכילה, לבוש, שירותים ורחצה	✓	✓	שעה				
	• תקשורת: "יצירת קשר"	✓		30 דקות				

קורס הכשרה המשכי
לעובד חדש תוך שנה
מקליטה ל 70 %
מהצוותים!

2 נק'

(לפחות 40 שעות)

למטפלים / כוחות עזר

תוכן עניינים-



התוכנית תכלול התייחסות

לנושאים הבאים: -

1. הכשרה מקצועית בנושאים רלוונטיים
(למשל טיפול בסיסי בדייר ADL-טיפול בדמנציה, פליאציה)
2. תקשורת עם הדייר
3. תפיסת הדייר במרכז ומענה לצרכיו
4. כבוד הדייר וזכויות הדייר לרבות שמירה על פרטיות
5. הבדלים בין תרבותיים
6. קשר עם בני משפחה
7. עבודת צוות
8. טיפול בסביבת הדייר
9. ניווד ומעברים, handling (מטפל ומטופל)
10. תפריטי מזון, הגשה וסיוע באכילה
11. דרכי דיווח ותיעוד
12. ניהול סיכונים ובטיחות הטיפול
13. התמודדות עם אובדן ומוות

עדכוני ידע/
העצמה ושימור –
מטפלים /
כוחות עזר



□ עדכון ידע – **20 שעות שנתיות** כגון
פדיקור, תעסוקה, ספרות, פעילות
גופנית... (2 נק')

□ העצמת מטפל - אחראי תחום כגון
חלוקת מזון, כביסה, קליטת עובד –
מטפל חדש (3 נק')

□ אפליקציות מונגשות למטפלים (1 נק')
רוחת העובד כגון עובד מצטיין (1 נק')

□ תוכניות שימור(ותק) וקידום עובדים
(4 נק').

עדכוני ידע/ העצמה ושימור – מטפלים / כוחות עזר



כתב מינוי



מ"מ רמ"מ ח"מ
ח"מ ח"מ ח"מ
ח"מ ח"מ ח"מ
ח"מ ח"מ ח"מ
ח"מ ח"מ ח"מ

לכבוד:

שם כוח עזר :
מחלקה: בבית הדר - מרכז רמ"מ שיקום וסיעוד.

שלום רב,

הנדון: מינוי לתפקיד כוח עזר אחראית מחסנים מחלקתית
ב"בית הדר - מרכז רמ"מ שיקום וסיעוד".

בזה אנו ממנים אותך לתפקיד כוח עזר אחראית מחסנים במחלקה ----, מתאריך *****
וזאת בהתאם לדרישות התפקיד והמטלות הנדרשות.

מינוי זה הינו תקופתי ויבחן מעת לעת.

אנו מאחלים לך הצלחה והמשך דרך פורייה בתפקידך.

על המינוי חתומים :

גבי מאיה שקולניק גיט
אחות ראשית

מר אריה סיון
מנהל אדמיניסטרטיבי

הנדרת תפקיד מטפלת אחראית מחסנים :

1. **מחסן כביסה :** פיקוח אחר סדר, ניקיון, בלאי, מלאי, שילוט ושימוש מתאים.
דיווח בהתאם לצרכי המחלקה לאם הבית ולאחות האחראית (מומלץ פגמים בשבוע לדיווח
בתחילת שבוע ובסוף שבוע).
2. **מחסן ציוד רפואי/נשימתי / אמצעי ספיגה והיגיינה אישית :** פיקוח אחר סדר, ניקיון ובלאי
דיווח בהתאם לצורך לגורם הרלוונטי.
3. **מחסן תרופות ומזון ייעודי :** פיקוח סדר וניקיון.
4. **מחסן מינוי פסולת וכביסה:** פיקוח אחר סדר, ניקיון, בלאי, מלאי, שילוט ושימוש מתאים. דיווח
בהתאם לצורך.

אחיות



אחיות מוסמכות

- כתב מינוי לתפקיד
- אחיות מוסמכות עם רשיון זמני- מנגנון פיקוח מתועד

- אחיות מעשיות – כוח מסייע
- פיתוח מקצועי (חת"ש) – 20 שעות

- קישור לנוהל מנהל האחיות 2017



הכשרות לאחיות – נאמני נושא (1 נק')

דרישות –

1. אחות מוסמכת.
2. בוגרת הכשרה 30 שעות או על בסיסי רלוונטי.
3. ותק מקצועי מעל חצי שנה .
4. כתב מינוי .
5. העסקה בהיקף לפחות 75% משרה ומשמרת 1-2 בוקר לפחות .

□ בכל מסגרת ימונו נאמני נושא ב- 3 נושאים
לפחות (במוסד קטן של 3 מחלקות עד 2
נושאים).

□ נאמני נושא יוכשרו ב- 30 שעות לפחות או
קורס על בסיסי רלוונטי או מומחיות קלינית.
□ קיום 3 מפגשים בשנה של נאמני נושא.

□ הנושאים לבחירה שיוכרו :

מניעה וטיפול בכאב / בפצע / עצירות
מניעת זיהומים / טיפול בדמנציה / טיפול
פליאטיבי / ניהול סיכונים ועוד....

הכשרות לאחיות – נאמני נושא (1 בק')

דוגמה



נספח מס' 6 כתב מינוי לתפקיד רכו/נאמן תחום

תאריך המינוי: _____

לכבוד:

שם האחיות: _____

מחלקה: _____ במרכז רפואה שיקום וסיעוד בית הדר (מ"יג).

שלום רב,

הנדון: מינוי לתפקיד רכות/נאמנת תחום מחלקתיות *****
ב "בית הדר - מרכז רפואה שיקום וסיעוד".

בוה אנו ממנים אותך לתפקיד רכות תחום ***** מתאריך *****
וזאת בהתאם לדרישות התפקיד והמטלות הנדרשות.

אנו מאחלים לך הצלחה והמשך דרך פורייה בתפקידך ובדרךך המקצועית.

על המינוי חתומים:

גב' מאיה שקולניק גזית
אחות ראשית

ד"ר משיעל יוסף
מנהל רפואי

נספח מס' 6 - המשך כתב מינוי לתפקיד רכו/נאמן תחום

1. דרישות התפקיד לנאמנת נושא מחלקתית -

- אחות מוסמכת בעלת רישיון לעסוק בסיעוד
- בעלת הכשרה פורמלית בתחום עליו היא ממונה
- עובדת בבית החולים הגריאטרי מעל ל-6 חודשים
- עובדת בבית החולים הגריאטרי משרה מלאה

2. תיאור עיקרי תפקיד ואחריות אחות רכות / נאמנת נושא מחלקתית

2.1. אחריות:

- אחראית להדרכת הצוות ולקידום איכות ומצוינות הטיפול הסיעודי בתחום עליו היא ממונה
- אחראית לתכנון והטמעת תוכנית עבודה שנתית, בהתאם לאיסוף נתונים וניתוחם תדאג להדרכה ויישום בהתאם.

2.2. עיקרי תפקיד:

מכינה תכנית עבודה שנתית, לאיסוף נתונים וניתוחם לקידום איכות ומצוינות הטיפול בתחום המוביל, בהתאם לאסטרטגיית משרד הבריאות ומנהל האחיות "מימוש הזכות לבריאות לכלל אוכלוסיית ישראל הכוללת:

1. מעלה מודעות לחשיבות התחום ולטיפול רב תחומי במטופל
2. מדריכה צוות לקידום איכות הטיפול בתחום עליו היא ממונה.
3. מפתחת, מקדמת הדרכות למטופל ומשפחתו
4. מתו יעוץ, כלים והדרכה לצוות לשימוש מותאם לצרכי המטופל תוך שיתוף מטופל/או בני משפחה
5. קיום קשר רציף בין נאמן מחלקתי לרכזת הנושא בביה"ח
6. מהווה משאב ידע עבור הצוות, המטופל ומשפחתו
7. מיידיעת את הצוות על חידושים ומנהלת מעקב אחר הכשרה פורמלית
8. מקדמת תוכניות מחלקתיות המבוססות על נהלי עבודה
9. הכרה, שותפות, בניה, עדכון והטמעת נהלים בהתאם לחוזרים של משרד הבריאות.
10. יוזמת הרצאות בישיבות צוות מחלקתיות
11. משתתפת במחקרים בתחום הקליני הספציפי
12. לקדם סטנדרטיזציה של רשומה רפואית שתאפשר איסוף ותייעוד של מידע קליני
13. איסוף נתונים/בקרה ופיקוח
14. שיקוף ומשוב ממצאי ביצוע תוכנית עבודה שנתית לצוותים ולהנהלה
15. להוביל את התוכנית למדדי איכות קליניים ארציים ומוסדיים.
16. להיות שותף בהגדרת מדדי איכות למוסד והטמעת אלגוריתם למדידה.
17. לנטר שיעור עמידה בכל מדד, לנסח המלצות ולקבוע מדיניות בנושאים הנמדדים.

דוגמה

[illegible]

עדכוני ידע – אחיות

(3 נק')



□ 50% - 70% ויותר בגין הקניית ידע

והשתלמויות לצוות במהלך שנתיים

אחרונות.

□ בהיקף **24 שעות** בנושאים כמו: מיומנויות

ניהוליות, תקשורת עם בני משפחה,

אוטונומיה, עבודה בצוות השתלמויות,

סוגיות בסוף החיים ועוד כולל כנסים

מקצועיים.

עדכוני ידע – אחיות (3 נק')

דוגמה



פרויקט – "מטפל עיקרי בקצה ובמרכז"



כלל מחלקות האשפוז הכרוני והפעיל	חטיבת מונשמים
שם הפעילות : " שיח מחזק"	נושא: " בוא נדבר על..... כוס קפה"
מטרה:	מטרה:
1. תמיכה ואוורור רגשי לצוות מתן מרחב בטוח לשיתוף, התלבטויות וביטוי עומסים כחלק משגרת העבודה.	1. מפגש עם בני משפחה באווירה אחרת
2. העמקת ידע מקצועי והעשרה בנושאים משתנים. לדוגמה:	2. היכרות עם הצוות הרב מקצועי
• זכויות מטופל ותקשורת מכבדת	3. יצירת ערוץ תקשורת ישיר ובלתי פורמלי
• מניעת התעמרות במסגרת סיעודית	4. העשרה במידע בתחומי טיפול שונים
• עבודה עם משפחות מורכבות	5. הפגת מתחים וחרדות
• טיפול במטופלים עם מאפיינים מיוחדים	
• רגישות לטיפול בניצולי שואה	פורום:
• אובדן עצמאות ותגובות רגשיות	אחות מפקחת מערך מונשמים, עו"ס
• עבודה עם מטופלים במצבי סוף חיים	קהל יעד:
• עבודה עם דיירים עם דמנציה	בני משפחות
• מניעת אלימות פיזית/מילולית	שיטה:
• הדרכה למניעת הטרדה מינית	מפגש שיח בן שעה וחצי, אחת לרבעון בין השעות 13:00-15:00 בתיאום מראש.
• שמירה וחיזוק החוסן קישור: מפת הדרכים לחוסן כלים מעשיים להתמודדות מיטבית (חוברת)	
• חשיבות הדיווח והעברת מידע בין משמרות/ מיצוי זכויות/סוגי תוקף משפטי ועוד.	
3. חיזוק שיתוף הפעולה בין הצוותים	
פורום:	
אחות אחראית, עו"ס	
קהל יעד:	
צוות מחלקה	
שיטה :	
מפגש מתואם במרחב המחלקה, עם צוות המשמרת הנוכח למשך כ- 20 דקות , אחד לחודש ומותאם לצרכי המחלקה.	

פיתוח מקצועי (חת"ש) – אחיות

(3 נק')



- לפחות 10 הדרכות בשנה
- השתתפות 70% מהצוות .
- פיתוח מקצועי (חת"ש) – 20 שעות הדרכה שנתיות.
- נושאים :
 - מניעה וטיפול בכאב / בפצע / עצירות
 - מניעת זיהומים / טיפול בדמנציה / טיפול
 - פליאטיבי וסוגיות בסוף החיים / ניהול סיכונים
 - ואירועים חריגים / מעברים / טיפול אישי /
 - תזונה / תקשורת / העשרת ידע בתחומים
- נוספים.

דוגמה



פיתוח מקצועי (חת"ש) – אחיות (3 נק')

תוכנית פגישות נאמני תחום שנתי - 2025

אחיות לביצוע משרד אחות ראשית - אחות אחראית פיתוח והכשרת חנויות
במוסד (בעני חת"ש)
פיתוח מקצועי שמירה על כשירות מקצועית (מיושם עם נאמני תחום)
אחת לרבעון (פברואר/יוני וספטמבר)



מועד לסיום	מועד התחלה	תחום	מועד לסיום	מועד התחלה	תחום
16/04-06/06-10/12/2025	16/04-06/06-10/12/2025	שיטת פגישות	16/04-06/06-10/12/2025	16/04-06/06-10/12/2025	שיטת פגישות
04/06-04/09-04/12-04/03/26	04/06-04/09-04/12-04/03/26	מיושם מושל בשיטת תרבות	04/06-04/09-04/12-04/03/26	04/06-04/09-04/12-04/03/26	מיושם מושל בשיטת תרבות
05/05-11/08-17/11-22/12/2025	05/05-11/08-17/11-22/12/2025	החייאת בשיתוף שימוש מושל	05/05-11/08-17/11-22/12/2025	05/05-11/08-17/11-22/12/2025	החייאת בשיתוף שימוש מושל
25/03	25/03	חונת והאכלה	25/03	25/03	חונת והאכלה
		דפוס חפירות			דפוס חפירות
		מניית התעמדות			מניית התעמדות
13/05/2025-12/08/2025	13/05/2025-12/08/2025	מניית יחוסים ודירות העובד	13/05/2025-12/08/2025	13/05/2025-12/08/2025	מניית יחוסים ודירות העובד

JANUARY	FEBRUARY	MARCH	APRIL	MAY	JUNE
5 M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	5 M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	5 M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	5 M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	5 M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	5 M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

אחיות ע"י בחירות

תוכנית הדרכה מוסדית שנתית - 2025

אחיות לביצוע משרד אחות ראשית - אחות אחראית פיתוח והכשרת חנויות במוסד (בעני חת"ש)

פיתוח מקצועי שמירה על כשירות מקצועית * ערכון ידע והדרכות לעזות * (השקעה 2 חמסך)



מועדי הדרכה	תחום הדרכה	מועדי הדרכה	תחום הדרכה
04-11-17-18/04/2025	שימוש מושל בשיטת תרבות - מניית יחוסים ודירות העובד	01-15-22-29/05/2025	תכנון תוכנית הדרכה - מניית יחוסים ודירות העובד
01-03-04-05/09/2025	מניית יחוסים ודירות העובד - מניית יחוסים ודירות העובד	08-12-19-26/09/2025	מניית יחוסים ודירות העובד - מניית יחוסים ודירות העובד
	מניית יחוסים ודירות העובד - מניית יחוסים ודירות העובד	01-08-15-22-29/12/2025	מניית יחוסים ודירות העובד - מניית יחוסים ודירות העובד
	מניית יחוסים ודירות העובד - מניית יחוסים ודירות העובד	10-17-24-31/03/2025	מניית יחוסים ודירות העובד - מניית יחוסים ודירות העובד
	מניית יחוסים ודירות העובד - מניית יחוסים ודירות העובד	8-16-23-30/04/2025	מניית יחוסים ודירות העובד - מניית יחוסים ודירות העובד
	מניית יחוסים ודירות העובד - מניית יחוסים ודירות העובד	03-10-17-24-31/10/2025	מניית יחוסים ודירות העובד - מניית יחוסים ודירות העובד

JANUARY	FEBRUARY	MARCH	APRIL	MAY	JUNE
5 M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	5 M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	5 M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	5 M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	5 M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	5 M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

38

39

40

דוגמה

- תוכן החת"ש נבנה בהתבסס על ספרות עדכנית בתחום האחיות הגריאטרית.
- משך כל מפגש שעה אקדמית.
- מומלץ לתאם את המפגשים לשעת חפיפת המשמרות 13:00 – 14:00

פיתוח מקצועי (חת"ש) – אחיות (3 נק')

הנושא	מדריך	באמצעות
1 בטיחות בביצוע מעברים פיזיים של דיירים	פיזיותרפיסט	הדרכה פיזית
2 מניעת התעמרות – מנגנון חובת הדווח	עו"ס	סדנא
3 תהליך נורמלי של ריפוי פצעים וגישה כוללנית לריפוי פצעים	אחות מוסמכת נאמנת נושא פצעים	הרצאה פרונטלית
4 גישה לחולה עם מחלות רקע שמלוות בכאב	אחות מוסמכת נאמנת נושא כאב	הרצאה פרונטלית
5 חוק החולה הנוטה למות והנחיות מקדימות	עו"ד	הרצאה פרונטלית
6 טיפול אישי בדייר – מקלחת, הלבשה, היגיינה אישית	אחות מוסמכת	סדנא
7 מרקמי מזון	תזונאית	הרצאה פרונטלית והדגמה
8 תוכנית שימור שליטה בסוגרים בקרב דיירים סיעודיים	אחות מוסמכת נאמנת נושא עצירות	הרצאה פרונטלית
9 שיטת התיקוף – יתרונות היישום בעבודה השוטפת	מרפאה בעיסוק	סרטון והדרכה פרונטלית
10 התמודדות עם אלימות והתנהגות מאתגרת של דיירים כלפי צוות	עו"ס	סדנא
11 תזונה ותוספי מזון	תזונאית	הרצאה פרונטלית והדגמה
12 שימוש מושכל באבזורים מגבילי תנועה	פיזיותרפיסט	הדרכה פיזית
13 טיפולים לא תרופתיים בדמנציה	אחות מוסמכת	הרצאה פרונטלית
14 חשיבות תעסוקה ושימוש נכון בסדים	מרפאה בעיסוק	הרצאה פרונטלית והדגמה
15 בטיחות בעבודה	אחות מוסמכת	הרצאה פרונטלית
16 תקשורת מסייעת עם בני משפחה של דיירים הלוקים בדמנציה	אחות מוסמכת נאמנת נושא דמנציה	הרצאה פרונטלית
17 שמיעה וראיה – שימוש באבזורים והטיפול בהם	אחות מוסמכת	הרצאה פרונטלית והדגמה
18 בטיחות הטיפול ואירועים חריגים	אחות מוסמכת	הרצאה פרונטלית
19 פתופיזיולוגיה וסמפטומים : אמן שיטתי של החולה הפליאטיבי	אחות מוסמכת נאמנת נושא פליאטיבי	הרצאה פרונטלית
20 שעת חרום ועבודה בעתות שגרת מלחמה	אחות מוסמכת	הרצאה פרונטלית

Comerford, K. (Ed.) (2020). Nursing Drug Handbook. Philadelphia, PA: Wolters.
Ignatavicius, D. D., Workman, M. L., Rebar, C. R., & Heimgartner, N. M. (2020).
Medical-Surgical Nursing-E-Book: Elsevier Health Sciences.

עדכון ידע - מקצועות הבריאות (1.5 נק')



עדכון ידע מקצועי- מקצועות הבריאות ועו"ס (1.5 נק' – 0.25 נק' לכל מקצוע)

הניקוד יינתן עבור השתלמויות מקצועיות חיצוניות לעדכון ידע למקצועות הבריאות ולעו"ס, אחת לשנתיים, בהתאם לטבלה להלן:

מקצוע	מס' שעות השתלמות לצוות המחלקה בשנתיים
פיזיותרפיה	20
ריפוי בעיסוק ועובדת תעסוקה	20 (מתוך זה לפחות 4 שעות לעובדת תעסוקה)
עו"ס	30
תזונה	16
קלינאות תקשורת	2
רוקחות	6



האתגר?



הכשרות
ופיתוח
15 נק'



מכרז החדש
2024



נתונים ל-
2024
והיסטוריית
המכרזים



מסגרות
ונותני שירות
בגריאטריה

תוכן עניינים

האתגר ?



מערכת הבריאות והסיעוד מתמודדת עם עלייה מתמשכת במספר המטופלים בגיל השלישי ובמקביל עם מחסור בכוח אדם מיומן.

חלק ניכר מהמטופלים הם דוברי שפות זרות, ולעיתים אינם מכירים את הסטנדרטים המקצועיים הנדרשים במוסדות גריאטריים, בעיקר בתחומי הטיפול הבסיסי (ADL, בטיחות, תקשורת טיפולית, מניעת זיהומים, זיהוי התדרדרות ועוד).

האתגר ?



כיום אין מערך הכשרה **אחיד**, מתועד,
נגיש ורב-לשוני המאפשר ללמד,
להעריך ולתעד רמת מיומנות של
מטפלים בצורה יעילה.

מטרה – פיתוח פלטפורמה דיגיטלית אינטגרטיבית אחידה, חדשנית ורב-לשונית להכשרת מטפלים דוברי שפות



1. *תכני לימוד מובנים, ויזואליים ומותאמים תרבותית*
2. *מערכת ריכוז ובקרה* לצפייה ומעקב אחר ביצוע ההכשרה
3. *הערכה ומשוב בזמן אמת*
4. *תיעוד מלא* לכל מטפל, כולל עמידה בדרישות חוקיות ותקניות
5. *הפקת תעודות הסמכה ממוחשבות* – חתומות על ידי גורם חיצוני מוכר/מוסמך
6. *מדידה שוטפת של איכות הביצוע בשטח* לאחר סיום ההכשרה.



הבעיה שאותה המערכת פותרת



- ☐ פערי שפה המובילים לטעויות בטיפול.
- ☐ חוסר אחידות בהדרכת מטפלים בין מוסדות.
- ☐ קושי למדוד / להעריך ביצוע בפועל בשטח.
- ☐ היעדר מערכת מסודרת לתיעוד והנפקת תעודות מקצועיות מאומתות.
- ☐ הדרכות פיזיות חוזרות.
- ☐ מחסור, זמינות ונגישות משאב אנושי מקצועי (אחיות וצוות פארמרפואי).
- ☐ סטאנדרט אחיד ותקני להכשרת צוותים ללא רקע מקצועי.

קורס הכשרה ראשוני בסיסי למטפלים במוסד גריאטרי



1. קורס הדיגיטלי כולל 10 מצגות לפי
תוכן עניינים של סילבוס מובנה עם
מבדק ידע.

קורס הכשרה ראשוני בסיסי למטפלים במוסד גריאטרי

תוכן עניינים-



קורס מטפלים במוסד גריאטרי תוכן עניינים

1 – היכרות עם עולם הזקנה, נורמות חברתיות ותרבותיות בישראל

2 – הגדרת תפקיד המטפל, תחומי אחריות, גבולות וסמכות

3 – היכרות עם שגרה וסדר יום במחלקות המוסד

4 – כללי בטיחות המטופל

5 – איכות החיים בזקנה

6 – זיהוי ודווח מצבים מיוחדים

7 – עקרונות הטיפול הבסיסי בזקן ADL

8 – טכניקות ניידות, מעברים הולכה

9 – שינויים תזונתיים בגיל הזקנה והשפעתם על תפקוד הזקן

10 – אחריות משמרת לילה



קורס הכשרה ראשוני בסיסי למטפלים במוסד גריאטרי

תוכן עניינים-



העמותה לקידום
הסיעוד הגריאטרי
בישראל

תחומי לימוד עיקריים

1. **זקנה ותהליכי חיים** – שינויים נורמטיביים, היבטים פסיכולוגיים, חברתיים ותרבותיים.
2. **תפקיד המטפל** – תחומי אחריות, גבולות תפקיד, סמכויות, עבודה מול צוות סיעודי.
3. **זכויות המטופל** – חוק זכויות החולה, כבוד האדם, סודיות רפואית.
4. **טיפול פליאטיבי ותומך** – התמודדות עם מחלות נפוצות בזקנה, אובדן ומוות, סוגיות אתיות.
5. **מניעת התעללות והזנחה** – הגדרות, סימנים מזהים, חובת דיווח, היבטים משפטיים.
6. **תקשורת מותאמת** – עם קשישים, משפחות וצוות רב־מקצועי; חיזוק מיומנויות בינאישיות.
7. **סיוע בפעולות יומיומיות** – היגיינה, האכלה, ניידות, שליטה בסוגרים, שינוי תנוחה, סדר יום.
8. **עבודת צוות** – חלוקת זמנים, סדרי עדיפויות, תיעוד ודיווח לאחות.
9. **בטיחות וניהול סיכונים** – מניעת נפילות, מניעת פצעי לחץ, היגיינת ידיים, מניעת זיהומים, עבודה בבידוד.
10. **התמודדות עם מצבי חירום** – שרפה, רעידת אדמה, ירי טילים, החייאה BLS.
11. **הדרכת פיזיותרפיה** – עקרונות ארגונומיה, שימוש נכון בגוף, נידוד בטוח של מטופלים.
12. **סיכום והענקת תעודות** – בסוף הקורס.

A woman with long dark hair is in the foreground, looking upwards and smiling. In the background, other people are visible, some holding up colorful sticky notes. The scene appears to be a collaborative meeting or workshop.

קישור לפודקאסט בנושא השלכות
המיכרז החדש על האשפוז הכרוני



סימוכין

<https://www.gov.il/he/pages/tender-offer-2024>

<https://www.gov.il/he/pages/m61-2024>

<https://www.gov.il/he/pages/hp-geriatric-regulations-nursing-mental-health-wards>

https://www.gov.il/he/departments/dynamiccollectors/inspections-tool?skip=0&inspections_units=3



Thank You



הצגת "המוצר"
על ידי אירה כהן.